DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: CARLOS HUMBERTO TAPASCO CANAS **Identificación** CC 14795117
Edad: 44 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS SA SUBSIDIADO 2025
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 04/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**441302**	**ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**	Y53	

Cirujano: JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES152 JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: C268 LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS

Dx Postoperatorio: C268 LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** SEDACION **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 04/11/26 **Fecha Final** 04/11/26
Hora Inicio 11:40:00 **Hora Final** 11:55:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PROCEDIMIENTO BAJO SEDACIÓN ANESTESIOLOGA DRA RODRIGUEZ (FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL).
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE
REALIZADO POR JEISSON HINCAPIE
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: ERGE
SE INTRODUCE GASTROSCOPIO OLYMPUS
ESOFAGO:MUCOSA NORMAL ,PASO FÁCIL POR EL CRICOFARINGEO, PERISTALTISMO, VASCULARIDAD,CONSERVADOS, LINEA A 38 COINCIDE CON LA IMPRESIÓN HIATAL.
ESTOMAGO: EXPLORADO HASTA PÍLORO INCLUYENDO RETROVISIÓN PARA PEQUEÑA CURVA Y FONDO GÁSTRICO DONDE SE EVIDENCIA LESION SUBHEPITELIAL EN CUERPO GASTRICO HACIA LA CURVATURA MAYOR DE APROX 1 CM DE DIAMETRO CENTRO UMBILICADO .
DUODENO: NORMAL HASTA SEGUNDA PORCIÓN
BIOPSIAS: NO
***CONCLUSION:
1. LESION SUBHEPITELIAL EN CUERPO GASTRICO HACIA LA CURVATURA MAYOR DE APROX 1 CM DE DIAMETRO CENTRO UMBILICADO CONSIDERAMOS SE DEBE REALIZAR ECO ENDOSCOPIA PARA CARACTERIZACION DE LA ALESION , Y TOMA DE BIOPSIA

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒

JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ
Reg. 1115066530
CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***